

跳到主要內容 :: | 網站導覽 (/sitemap_new) | 登入 (/gslogin) | 註冊 (/gspsignup)



衛生福利部食品藥物管理署

藥品仿單查詢平台

(/)

::: 公告訊息 (/notice) 仿單查詢 (/im) 批次訂閱 (/im_batch)
訂閱清單 (/im_subscribe) 藥品外觀資料查詢 (/shape_list)

:::

字級

中文品名 ▶ 欣剋融呼吸道融合病毒疫苗

英文品名 ▶ **Arexvy Respiratory Syncytial Virus Vaccine**

許可證號 ▶ 衛部菌疫輸字第**001251**號

藥品類別 ▶ 須由醫師處方使用

劑型 ▶ 注射用凍晶粉末與注射用懸浮液劑

申請商名稱 ▶ 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

申請商地址 ▶ 臺北市大同區承德路**1**段**2**號**20**樓

發證日期 ▶ **113-01-30**

有效日期 ▶ **118-01-30**

通關簽審文件編號 ▶ **DHA06000125109**

限制項目 ▶ 輸入,免除銜接性試驗

包裝 ▶ 每盒一百支以下玻璃小瓶裝附等支數
單劑量**0.5**毫升玻璃小瓶裝佐劑瓶裝
佐劑

仿單無紙化 ▶ 已採用

主製造廠

製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.**

製造廠地址 ▶ **Parc de la Noire Epine, Avenue Fleming 20, Wavre, 1300, Belgium**

m (Belgium)

次製造廠

- 製造廠名稱 ▶ **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (製程：放行廠)**
- 製造廠地址 ▶ **89 RUE DE L'INSTITUT 1330 RIXENSART, BELGIUM (Belgium)**
- 製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l**
- 製造廠地址 ▶ **BELLARIA ROSIA 53018 SOVICELLE (SIENA), ITALY (Italy)**
- 製造廠名稱 ▶ **裕利股份有限公司 (製程：二級包裝廠)**
- 製造廠地址 ▶ **桃園市大園區和平里1鄰開和路91號 (TAIWAN, ROC)**

(/compare/衛部菌疫輸字第001251號)

全部縮合

1 性狀

1.1 有效成分及含量

泡製之後，1劑(0.5毫升)含有120微克RSVPreF3¹抗原(使用AS01_E佐劑²)。

¹穩定於融合前構形(pre-fusion conformation)的呼吸道融合病毒(RSV)醣蛋白F(RSVPreF3)乃是利用DNA重組技術在中國倉鼠卵巢(CHO)細胞中製造而得。

²葛蘭素史克公司的專利AS01_E佐劑系統係由植物萃取物 *Quillaja saponaria* Molina的fraction 21 (QS-21) (25微克)與 *Salmonella minnesota* 的3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) (25微克)所組成。

1.2 賦形劑

粉劑(RSVPreF3抗原)：

二水海藻糖、聚山梨醇酯80、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀

懸浮液(AS01_E佐劑系統)：

二油醯基磷脂醯膽鹼、膽固醇、氯化鈉、無水磷酸氫二鈉、磷酸二氫鉀、注射用水

1.3 劑型

注射用凍晶粉末與注射用懸浮液劑。

1.4 藥品外觀

粉劑為白色。

懸浮液為乳白色、無色至淡棕色的液體。

2 適應症

適用於下列成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病(lower respiratory tract disease, LRTD)。

- 50歲以上成人
- 發生RSV疾病風險較高之18至49歲成人

3 用法及用量

3.1 用法用量

Arexvy僅供肌肉注射使用，最合適的注射部位是三角肌，投予劑量為單劑0.5毫升。

關於施打本藥品前的泡製指示，請參見調製方式。

3.2 調製方式

製備

Arexvy以兩個小瓶方式提供，在施打前必須先進行泡製。透過搭配的懸浮液佐劑成分(乳白色、無色至淡棕色的無菌液體)泡製凍乾抗原成分(無菌白色粉末)來製備Arexvy。只能使用提供的懸浮液佐劑成分來泡製。泡製後的疫苗為乳白色、無色至淡棕色的液體。

施打前應目視檢查泡製後的疫苗是否有微粒異物及顏色改變的現象。如果有上述任何一種現象，不應施打此疫苗。

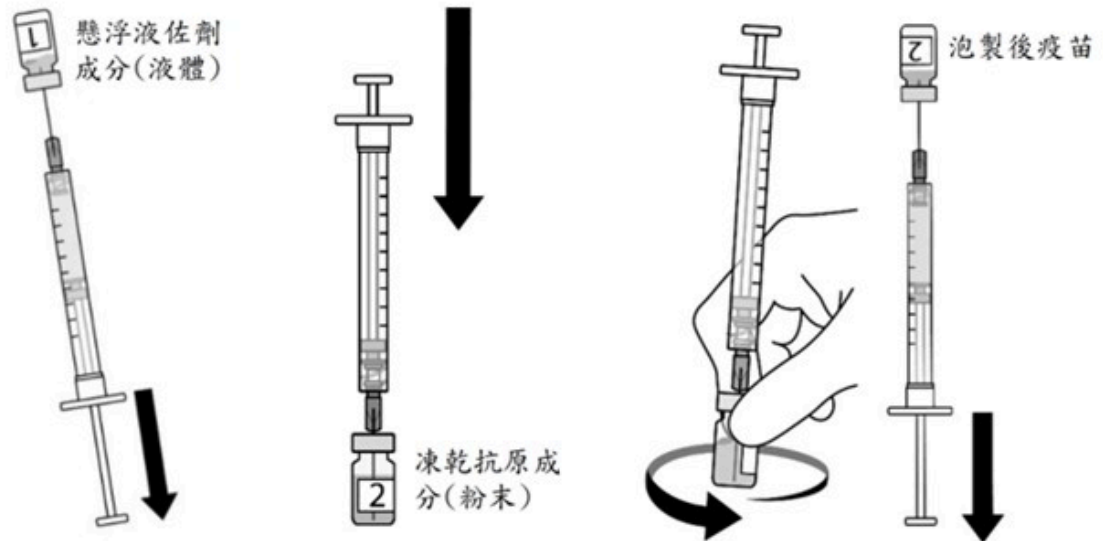


圖 1、清潔兩個小瓶的瓶塞。使用無菌針頭(21G 至 25G)和無菌注射針筒，透過稍微傾斜小瓶，將小瓶內含有懸浮液佐劑成分(液體)的內容物全部抽出。圖示為 2 瓶中的第 1 瓶。

圖 2、緩慢地將針筒中的內容物注入裝有凍乾抗原成分(粉末)的小瓶中。圖示為 2 瓶中的第 2 瓶。

圖 3、輕輕旋轉，直到小瓶中的粉劑完全溶解。**切勿劇烈搖晃。**

圖 4、在泡製後，從含有泡製後疫苗的小瓶中取出 0.5 毫升，並進行肌肉注射。

施打

僅適用於肌肉注射。

泡製之後，立即施打 Arexvy，或避光保存於冰箱中 2°C–8°C (36°F 至 46°F) 或放在室溫 (最高 25°C (77°F))，並於 4 小時內使用。若未能於 4 小時內使用，請丟棄該疫苗。

4 禁忌

對本疫苗的活性成分或任何組成嚴重過敏(參見有效成分及含量與賦形劑)。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

進行免疫接種之前

和所有的注射用疫苗一樣，應隨時備妥適當的醫療與監督措施，以防接種此疫苗之後發生過敏性事件。

和其他疫苗一樣，罹患急性嚴重發燒性疾病的病人宜延後接種Arexvy。但不須因出現輕微的感染現象(如感冒)而延後接種疫苗。

和所有的疫苗一樣，並非所有的疫苗接種者都可產生具保護性的免疫反應。

在施打任何疫苗之後(甚至之前)都可能會因對針頭注射產生心理性反應而發生暈厥(昏倒)的現象。因此一定要在適當的場所施打疫苗，避免因昏倒而受傷。

使用注意事項

切勿以血管內或皮內注射的方式投予本疫苗。目前並無任何關於以皮下注射方式投予 Arexvy 的資料。

和其他以肌肉注射方式投予的疫苗一樣，對患有血小板減少症或任何凝血障礙疾病的人施打Arexvy時應謹慎，因為這些病人在接受肌肉注射之後可能會發生出血的現象。

全身性免疫抑制藥物與免疫功能不全

目前並無Arexvy用於免疫功能低下者之安全性和免疫生成性方面的資料。接受免疫抑制治療的病人或免疫功能不全的病人對Arexvy的免疫反應可能會降低。

格林-巴利症候群(Guillain-Barré syndrome)

上市後觀察性研究結果顯示，接種本品後42天內發生格林-巴利症候群的風險增加(參見8.3 上市後經驗)。

5.3 操作機械能力

目前尚未進行過Arexvy對駕駛能力和機械操作能力之影響方面的研究。

Arexvy 可能對駕駛和機械操作的能力有輕微影響。第 8.1 節「臨床重要副作用/不良反應」中所提到的影響（例如疲勞）可能會暫時影響駕駛或機械操作能力。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

目前並無懷孕婦女使用Arexvy的臨床試驗資料。

在一項臨床試驗中對3557名孕婦施打研究用無佐劑但與Arexvy同樣含有RSVPreF3抗原的疫苗後，觀察到與安慰劑組相比早產兒有增加的情形。目前對於無佐劑RSVPreF3疫苗施打和早產之間的關係尚未有結論。

一項在雌性兔子進行的發育與生殖毒性試驗，於交配前或懷孕期間施打Arexvy(每次0.5 mL)，結果顯示對雌性生育力、胚胎-胎兒、斷奶前和出生後發育沒有不良影響(參見數據)。

Arexvy並不適用於孕婦。

6.1.1 數據

動物數據：在一項發育毒性試驗中，雌性兔子在交配前28天和14天、懷孕第3、9、16和24天以及哺乳期第7天，經由肌肉注射Arexvy，每次劑量為0.5 mL(Arexvy單次臨床劑量為0.5 mL)，未觀察到對於雌性生育力或斷奶前直到出生後第35天的發育有不良影響。

6.2 哺乳

目前並無Arexvy於人類或動物乳汁中分泌的資料。
Arexvy並不適用於餵哺母乳/授乳的婦女。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前並無Arexvy對人類生育力之影響方面的資料。
動物實驗並未發現Arexvy對雌性生育力的直接或間接有害影響。(參見10.3臨床前安全性資料)

7 交互作用

與其他疫苗併用

Arexvy可與去活化季節性流感疫苗(標準劑量無添加佐劑、高劑量無添加佐劑或標準劑量有添加佐劑)、帶狀疱疹疫苗(基因重組、有添加佐劑)或肺炎鏈球菌結合型疫苗(載體蛋白為白喉CRM₁₉₇蛋白質)同時施打。兩者同時施打時的安全性概況，與單獨施打Arexvy大致相當。免疫生成性方面的資料請參見臨床試驗資料。

如果要將Arexvy和另一種注射用疫苗同時施打，應將兩種疫苗施打於不同的注射部位。

目前尚無針對Arexvy與上述疫苗以外的其他疫苗併用之可用資料。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

安全性資料概況

以下的安全性概況及不良反應列表(表1)係以一項針對60歲以上成人，在歐洲、北美洲、亞洲和南半球進行的安慰劑對照第III期臨床試驗(RSV OA=ADJ-006)為基礎，其中有超過12,000位受試者接種一劑Arexvy，以及超過12,000位受試者接種安慰劑，追蹤時間約為12個月。

在60歲以上的受試者中，最常通報的不良反應為注射部位疼痛(61%)、疲倦(34%)、肌痛(29%)、頭痛(28%)及關節痛(18%)。這些不良反應通常是輕度或中度，並且在疫苗接種後幾天內緩解。

其他大部分的不良反應是少見的，且於接受Arexvy或安慰劑的受試者中有相似的通報情形。

不良反應列表

不良反應依MedDRA系統器官類別和發生頻率列出如下：

極常見	(≥1/10)
常見	(≥1/100至<1/10)
少見	(≥1/1,000至<1/100)
罕見	(≥1/10,000至<1/1,000)
極罕見	(<1/10,000)

表 1. 不良反應

系統器官類別	發生頻率	不良反應
血液與淋巴系統疾患	少見	淋巴結病變
免疫系統疾患	少見	過敏反應(如皮疹)
神經系統疾患	極常見	頭痛
胃腸道疾患	少見	噁心、腹痛和嘔吐
肌肉骨骼與結締組織疾患	極常見	肌痛、關節痛
全身性疾患與投藥部位症狀	極常見	注射部位疼痛、疲倦
	常見	注射部位紅斑、注射部位腫脹、發燒、發冷
	少見	注射部位搔癢
		疼痛、不適

此外，在一項安慰劑對照第III期臨床試驗(RSV OA=ADJ-018)中，有769位50至59歲的受試者(包括386位患有會導致發生RSV疾病風險升高的預設穩定慢性疾病的受試者)和381位60歲以上的受試者接種一劑Arexvy。另在一項開放性第III期臨床試驗(RSV OA=ADJ-025)中，有1,029位18至49歲患有會導致發生RSV疾病風險升高的預設穩定慢性疾病的受試者，以及429位60歲以上的受試者接種一劑Arexvy。在這兩項試驗中，50至59歲及18至49歲的受試者最常通報的不良反應為注射部位疼痛(76%及76%)、疲倦(40%及60%)、肌痛(36%及60%)、頭痛(32%及44%)和關節痛(23%及28%)，且發生率都高於其試驗中60歲以上的受試者。

這兩項試驗所通報的不良反應和表1所列的不良反應大致相似，惟有兩項例外：其一為注射部位紅斑，在50至59歲受試者中被通報為「極常見」，而在60歲以上及18至49歲受試者中則被通報為「常見」；其二為噁心，在18至49歲受試者中被通報為「常見」，而在50歲以上受試者中則被通報為「少見」。

8.3 上市後經驗

神經系統異常：格林-巴利症候群

上市後，自發性通報的疫苗不良事件通報系統(VAERS)資料顯示，2023年5月3日至2024年4月14日期間，接種疫苗後之GBS不良事件通報值高於背景預期值。

一項利用Medicare醫療保險資料庫進行之自我對照案例系列研究，分析2023年5月至2024年7月期間接種本品之65歲以上成人發生格林-巴利症候群(GBS)之風險，分析中設定的風險期為接種疫苗後第1至第42天，對照期為第43天至第90天。研究結果顯示，接種後42天內發生格林-巴利症候群之風險增加，其發生率比(Incidence Rate Ratio，風險期內GBS病例數與對照期內病例數之比)為2.46 (95%CI 1.19-5.08)，估計65歲以上成人每接種百萬劑疫苗後會多增加7例格林-巴利症候群案例。然研究族群中的格林-巴利症候群背景風險會影響格林-巴利症候群超額案例數(excess case)的估計值，不同研究間亦可能存在差異，因此應避免與其他疫苗或其他族群研究之超額案例數估計值直接比較。

上述醫療保險資料庫中格林-巴利症候群案例的診斷分析，具有經病歷審視確認為格林-巴利症候群之案例分析，以及單獨接種本品且未同時接種其他疫苗之案例分析的支持。然應注意美國VAERS資料與此研究雖指出接種本品可能增加格林-巴利症候群發生之風險，但目前臨床證據仍不足以確立兩者間之因果相關性。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Arexvy誘發對抗RSVPreF3的免疫反應，進而預防由RSV造成的LRTD。

10.2 藥效藥理特性

藥物治療分類：疫苗、其他病毒疫苗，ATC編碼：J07BX05。
參見12 臨床試驗資料

10.3 臨床前安全性資料

10.3.1 致癌性、致突變性及生育力損傷

目前尚未進行Arexvy的致癌性、致突變性或雄性生育力損傷的評估。
一項在兔子進行的Arexvy生殖和發育試驗，結果未顯示對於雌性生育力、懷孕或胚胎-胎兒或子代發育產生疫苗相關影響(參見6.1 懷孕)。

11 藥物動力學特性

疫苗不須評估藥物動力學特性。

12 臨床試驗資料

疫苗療效

在RSV OA=ADJ-006試驗中，曾針對60歲以上成人評估Arexvy在長達3個RSV流行季期間對預防RSV相關LRTD的疫苗療效，這是一項在北半球和南半球17個國家進行的第III期、隨機分派、安慰劑對照、觀察者盲性臨床試驗。

疫苗療效分析的主要族群(校正曝藥族群)為接受1劑Arexvy或安慰劑的60歲以上成人，並且在接種疫苗後第15天之前未曾通報確定為RSV引起的急性呼吸道疾病(ARI)。

第一個RSV流行季期間的主要疫苗療效分析族群包括24,960位接種1劑Arexvy (N=12,466)或安慰劑(N=12,494)的受試者。受試者的中位數年齡為69歲(範圍：59到102歲)，大約有74%超過65歲、44%超過70歲及8%超過80歲。大約有52%是女性。在基礎期時，有39.3%的受試者患有至少一種關注共病症；有19.7%的受試者原先即患有心肺疾病(慢性阻塞性肺病、氣喘、任何慢性呼吸道/肺部疾病、或慢性心臟衰竭)，有25.8%的受試者患有內分泌或代謝疾病(糖尿病、晚期肝臟或腎臟疾病)。在進行2個和3個RSV流行季之疫苗療效分析時的校正曝藥族群受試者中，人口統計學概況與基礎期特性都和進行第一個RSV流行季之疫苗療效分析時的校正曝藥族群受試者類似。

確定RSV病例都是透過針對鼻咽拭子檢體進行定量反轉錄聚合酶連鎖反應(qRT-PCR)檢測的結果來判定。

LRTD的定義係基於以下標準：受試者必須出現至少2種下呼吸道症狀/徵兆，其中包括至少1種下呼吸道徵兆，且持續至少24小時；或必須出現至少3種下呼吸道症狀，且持續至少24小時。下呼吸道症狀包括：新發生或增加的痰液，新發生或加劇的咳嗽，新發生或加劇的呼吸困難(呼吸急促)。下呼吸道徵兆包括：新發生或加劇的喘鳴、濕囉音/囉音、呼吸速率 ≥ 20 次/分鐘、血氧飽和度偏低或降低(血氧飽和度 $<95\%$ ，或 $\leq 90\%$ (如果基礎值為 $<95\%$))或須補充氧氣。

重度RSV相關LRTD的定義為經qRT-PCR確認與RSV相關的LRTD，且帶有至少2種下呼吸道徵兆，或妨礙正常的日常活動或需要支持性治療。

在第一個RSV流行季期間對RSV相關LRTD的疫苗療效

主要目的為證實疫苗在第一個RSV流行季期間首次發生確定RSV-A及/或RSV-B相關LRTD的預防效果。

表2列出整體及子群在第一個RSV流行季期間之疫苗療效。

在60歲以上的受試者中，預防接種15天後首次出現RSV相關的LRTD的疫苗療效相較於安慰劑組為82.6% (96.95% CI為57.9%到94.1%)。在6.7個月的中位數追蹤期間可觀察到疫苗對RSV-LRTD的預防效果。疫苗對RSV-A相關LRTD和RSV-B相關LRTD的預防效果分別為84.6% (95% CI [32.1, 98.3])和80.9% (95% CI [49.4, 94.3])。

表 2. 第一個 RSV 流行季期間之疫苗療效分析：整體受試者、年齡子群和共病症子群中，首次發生 RSV 相關 LRTD 的病例 (校正曝藥族群)

子群	Arexvy			安慰劑			% 疫苗療效 (CI) ^a
	N	n	每 1,000 人年的發生率	N	n	每 1,000 人年的發生率	
整體 (≥ 60 歲) ^b	12466	7	1.0	12494	40	5.8	82.6 (57.9, 94.1)
60-69 歲	6963	4	1.0	6979	21	5.5	81.0 (43.6, 95.3)
70-79 歲	4487	1	0.4	4487	16	6.5	93.8 (60.2, 99.9)
≥ 80 歲	1016	2	3.6	1028	3	5.4	無法可靠地估算 ^c
患有至少 1 種關注共病症的受試者	4937	1	0.4	4861	18	6.6	94.6 (65.9, 99.9)

^a CI=信賴區間(整體(≥ 60歲)分析為96.95%，所有子群分析皆為95%)。對於整體受試者(≥ 60歲)和患有至少1種關注共病症之受試者的分析，疫苗療效的雙邊分析精確信賴區間乃是以依年齡層和地區進行校正的Poisson模型為基礎而得出的。年齡子層的子群分析則是依地區進行校正而得。

^b主要的確認性目標，預設的成功標準為疫苗療效的雙邊分析CI下限超過20%。

^c因為此年齡群累積的病例數太少。

N=各組中的受試者人數

n=接種疫苗第15天後首次發生確定RSV LRTD的受試者人數

在第一個RSV流行季期間對重度RSV相關LRTD的疫苗療效

在60歲以上的受試者中，和安慰劑相比較，Arexvy可使發生重度RSV相關LRTD的風險降低94.1% (95% CI [62.4, 99.9])。Arexvy組有1個通報發生重度RSV相關LRTD的病例，安慰劑組則有17例，其中有4例需要支持性治療(補充氧氣)。

橫跨2個RSV流行季期間和3個RSV流行季期間對RSV相關LRTD的疫苗療效

針對接種1劑Arexvy或安慰劑的受試者在3個RSV流行季期間進行追蹤，橫跨2個RSV流行季期間的中位數追蹤時間為17.8個月(截至北半球第二個流行季結束)，橫跨3個RSV流行季期間的中位數追蹤時間為30.6個月(截至北半球第三個流行季結束)。在60歲以上的受試者中，橫跨2個RSV流行季期間，疫苗對RSV相關LRTD的預防效果為67.2% (97.5% CI [48.2, 80.0])，橫跨3個RSV流行季期間則為62.9% (97.5% CI [46.7, 74.8])。

橫跨3個RSV流行季期間，疫苗對RSV-A相關LRTD和RSV-B相關LRTD的預防效果分別是69.8% (97.5% CI [42.2, 85.7])和58.6% (97.5% CI [35.9, 74.1])。

表3列出整體及子群在橫跨2個RSV流行季期間和3個RSV流行季期間之疫苗療效。

表 3. 橫跨 2 個 RSV 流行季期間和 3 個 RSV 流行季期間之疫苗療效分析：整體受試者、年齡子群和共病症子群中，首次發生 RSV 相關 LRTD 的病例 (校正曝藥族群)

子群	Arexvy ^a			安慰劑			% 疫苗療效 (CI) ^c
	N ^b	n	每 1,000 人年的 發生率	N ^b	n	每 1,000 人年的 發生率	
橫跨 2 個 RSV 流行季期間							
整體 (≥60 歲)	12469	30	2.0	12498	139	8.0	67.2 (48.2, 80.0)
60 至 69 歲	6963	17	2.1	6981	74	7.7	65.4 (40.4, 80.9)
70 至 79 歲	4489	9	1.7	4489	55	8.8	74.9 (48.4, 89.2)
≥80 歲	1017	4	3.5	1028	10	7.2	無法可靠地估算 d
患有至少 1 種關注共病 症的受試者	4983	16	2.7	4919	72	10.6	66.7 (41.8, 82.0)
橫跨 3 個 RSV 流行季期間							

整體 (≥60 歲)	12468	48	2.4	12498	215	7.9	62.9 (46.7, 74.8)
60 至 69 歲	6962	28	2.5	6981	117	7.6	60.3 (39.5, 74.8)
70 至 79 歲	4489	15	2.1	4489	85	8.6	70.6 (48.4, 84.3)
≥80 歲	1017	5	3.3	1028	13	6.0	無法可靠地估算 ^d
患有至少1 種關注共病症 的受試者	5014	25	3.2	4951	116	10.8	64.7 (45.1, 78.1)

^a 若受試者於第2個流行季前隨機分派至接種第二劑AREXVY，則該受試者在接種第二劑時即視為設限。

^b 由於試驗期間進行了多次分析，部分受試者資料有所更新，歷次分析中所涵蓋的受試者人數不盡相同。

^c CI=信賴區間(整體(≥ 60歲)分析為97.5%，所有子群分析皆為95%)。對於整體受試者(≥ 60歲)和患有至少1種關注共病症之受試者的分析，疫苗療效的雙邊分析精確信賴區間乃是以依年齡層、地區和流行季進行校正的Poisson模型為基礎而得出的。年齡子層的子群分析則是依地區和流行季進行校正而得。

^d 因為此年齡群累積的病例數太少。

N=各組中的受試者人數

n=接種疫苗第15天後首次發生確定RSV LRTD的受試者人數

在60歲以上的受試者中，橫跨2個RSV流行季期間，疫苗對重度RSV相關LRTD的預防效果為78.8% (95% CI [52.6, 92.0]) (Arexvy組7例，安慰劑組48例，其中有1個Arexvy組病例和5個安慰劑組病例需要支持性治療[補充氧氣和正壓呼吸器])。

在60歲以上的受試者中，橫跨3個RSV流行季期間，疫苗對重度RSV相關LRTD的預防效果為67.4% (95% CI [42.4, 82.7]) (Arexvy組15例，安慰劑組75例，其中有2個Arexvy組病例和5個安慰劑組病例需要支持性治療[補充氧氣和正壓呼吸器])。

在第二個RSV流行季期間和第三個RSV流行季期間對RSV相關LRTD的預防效果
在60歲以上的受試者中，在第二個RSV流行季期間(中位數追蹤時間為6.3個月)，疫苗對RSV相關LRTD的預防效果為56.1% (95% CI [28.2, 74.4]) (Arexvy組20例，安慰劑組91例)。

在60歲以上的受試者中，在第三個RSV流行季期間(中位數追蹤時間為7.0個月)，疫苗對RSV相關LRTD的預防效果為48.0% (95% CI [8.7, 72.0]) (Arexvy組16例，安慰劑組61例)。

再次接種的必要性

再次接種疫苗的必要性尚未確立。

在RSV OA=ADJ-006試驗中，曾在第二個RSV流行季之前，針對先前接種Arexvy的受試者重新隨機分組至接種安慰劑或第二劑Arexvy，在第一個流行季之前接種安慰劑的受試者於第二個流行季之前接種第二劑安慰劑。此部分試驗結果顯示第一劑疫苗接種12個月後接種第二劑疫苗並沒有增加疫苗療效。

接種一劑Arexvy疫苗對RSV相關下呼吸道疾病(LRTD)的疫苗療效，在橫跨3個RSV流行季期間，仍可達到試驗預設的成功標準(雙邊分析CI下限超過20%)。

Arexvy的免疫原性

50至59歲及發生RSV疾病之風險較高的18至49歲成人

曾在兩項試驗中評估Arexvy在18至59歲成人所引發的免疫反應和已證實疫苗對RSV相關LRTD預防效果之60歲以上成人的免疫反應之不劣性比較；包括一項第III期、觀察者盲性、隨機分派、安慰劑對照試驗(RSV OA=ADJ-018)和一項第III期開放性試驗(RSV OA=ADJ-025)。

在RSV OA=ADJ-018試驗中，族群1係由50至59歲的受試者組成，並依其病史分成2個子群。子群1 (adults at increased risk, Adults-AIR)係由患有會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病(如慢性肺病、慢性心血管疾病、糖尿病、慢性腎病或肝病)的受試者組成(Arexvy組，N=386；安慰劑組，N=191)。子群2 (Adults-non-AIR)係由未患有預設穩定慢性疾病的受試者組成(Arexvy組，N=383；安慰劑組，N=192)。族群2 (OA, older adults)係由60歲以上的受試者組成(Arexvy組，N=381)。

RSV OA=ADJ-025試驗由18至49歲患有會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病(如慢性肺病、慢性心血管疾病、糖尿病、慢性腎病或肝病、神經系統或神經肌肉疾病)的受試者(總人數N=1,029；其中有426位為免疫原性分析子群的一部分)，以及60歲以上的受試者(N=429)組成。所有受試者都接種一劑Arexvy。

主要免疫原性目的為證明在患有或未患有會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病的50至59歲受試者，以及患有會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病的18至49歲受試者中，接種Arexvy疫苗1個月後所引發的體液免疫反應(根據RSV-A和RSV-B中和效價)和60歲以上受試者的不劣性比較。

在50至59歲成人(表4)及發生RSV疾病之風險較高的18至49歲成人(表5)中，RSV-A與RSV-B中和效價免疫反應均達到預設的不劣性標準。可根據在60歲以上成人中已獲得證實的疫苗預防效果，推論Arexvy在前述兩族群中的預防效果。

表 4. 60 歲以上的成人 (OA) 和患有或未患有 (Adults-AIR 或 Adults-non-AIR) 會導致發生 RSV 疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病^a 的 50 至 59 歲成人相比較，RSV-A 與 RSV-B 中和效價 (ED60) 的調整後 GMT、SRR 值、調整後 GMT 比率和 SRR 差異摘要 – 依計劃書分析 (per protocol set)

RSV-A中和效價(ED60)				
	調整後 GMT (95% CI)	調整後 GMT 比率(95% CI) ^b	SRR (%) (95% CI)	SRR 差異 (95% CI) ^c
OA (≥ 60 歲)	7440.1 (6768.4, 8178.5)	0.83 (0.73, 0.95)	80.4 (75.8, 84.5)	-6.5 (-12.1, -0.9)
Adults-AIR (50 至 59 歲)	8922.7 (8118.2, 9806.9)		86.9 (82.8, 90.3)	
OA (≥ 60 歲)	7492.6 (6819.1, 8232.7)	0.95 (0.83, 1.09)	80.4 (75.8, 84.5)	-2.4 (-8.3, 3.5)
Adults-non-AIR (50 至 59 歲)	7893.5 (7167.5, 8692.9)		82.8 (78.3, 86.8)	
RSV-B中和效價(ED60)				
	調整後 GMT (95% CI)	調整後 GMT 比率 ^b	SRR (95% CI)	SRR 差異 ^c
OA (≥ 60 歲)	8062.8 (7395.9, 8789.9)	0.80 (95% CI [0.71, 0.91])	74.5 (69.5, 79.0)	-7.2 (95% CI [-13.3, -0.9])
Adults-AIR (50 至 59 歲)	10054.7 (9225.4, 10958.7)		81.6 (77.1, 85.6)	

OA (≥ 60 歲)	8058.2 (7373.1, 8807.0)	0.89 (97.5% CI [0.77, 1.03])	74.5 (69.5, 79.0)	-3.7 (97.5% CI [-11.1, 3.7])
Adults-non-AIR (50 至 59 歲)	9009.5 (8226.8, 9866.6)		78.2 (73.3, 82.6)	

^a預設穩定慢性疾病，如慢性肺病、慢性心血管疾病、糖尿病、慢性腎病或肝病。

^{b,c}預設免疫反應不劣性標準的定義為在60歲以上的受試者(OA)和患有或未患有(Adults-AIR或Adults-non-AIR)會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病的50至59歲受試者相比較，調整後GMT比率(OA除Adults-AIR或Adults-non-AIR)雙邊分析95%或97.5%信賴區間上限≤1.5且SRR差異(OA減Adults-AIR或Adults-non-AIR)雙邊分析95%或97.5%信賴區間上限≤10%。

ED60 (estimated dilution 60)：估計稀釋度60；CI=信賴區間；GMT (geometric mean titer)=幾何平均效價；SRR (seroresponse rate)=血清反應率

表 5. 60 歲以上的成人 (OA) 和患有會導致發生 RSV 疾病之風險升高 (Adults-AIR) 的預設穩定慢性疾病^a 的 18 至 49 歲成人相比較，RSV-A 與 RSV-B 中和效價 (ED60) 的調整後 GMT、SRR 值、調整後 GMT 比率和 SRR 差異摘要 – 依計劃書分析 (per protocol set)

RSV-A 中和效價 (ED60)				
	調整後 GMT (95% CI)	調整後 GMT 比率 (95% CI) ^b	SRR (%) (95% CI)	SRR 差異 (95% CI) ^c
OA (≥ 60 歲)	8591.5 (7902.7, 9340.3)	0.72 (0.64, 0.81)	77.7 (73.4, 81.6)	-9.4 (-14.6, -4.1)
Adults-AIR (18 至 49 歲)	11914.6 (10933.2, 12984.2)		87.1 (83.3, 90.2)	
RSV-B 中和效價 (ED60)				
	調整後 GMT (95% CI)	調整後 GMT 比率 (95% CI) ^b	SRR (95% CI)	SRR 差異 (95% CI) ^c

OA (≥ 60 歲)	9087.6 (8372.1, 9864.2)	0.73 (0.65, 0.82)	77.2 (72.9, 81.2)	-10.1 (-15.3, -4.8)
Adults-AIR (18 至 49 歲)	12503.4 (11490.5, 13605.4)		87.3 (83.6, 90.4)	

^a預設穩定慢性疾病，如慢性肺病、慢性心血管疾病、糖尿病、慢性腎病或肝病、神經系統或神經肌肉疾病。

^{b,c}預設免疫反應不劣性標準的定義為在60歲以上的受試者(OA)和患有(Adults-AIR)會導致發生RSV疾病之風險升高的預設穩定慢性疾病的18至49歲受試者相比較，調整後GMT比率(OA除Adults-AIR)雙邊分析95%信賴區間上限≤1.5且SRR差異(OA減Adults-AIR)雙邊分析95%信賴區間上限≤10%。

ED60：估計稀釋度60；CI=信賴區間；GMT=幾何平均效價；SRR=血清反應率

同時接種疫苗後的免疫生成性

與流感疫苗同時接種

在三項開放性第III期臨床試驗中，受試者於隨機分組後接種1劑Arexvy，並於當天同時接種或間隔1個月後分開接種去活化季節性四價流感疫苗(標準劑量無添加佐劑，成人 ≥ 60 歲，N=885；高劑量無添加佐劑，成人 ≥ 65 歲，N=1,029；或標準劑量有添加佐劑，成人 ≥ 65 歲，N=1,045)。

將Arexvy與標準劑量無添加佐劑的季節性流感疫苗同時接種時，RSV-A與四種中任一種流感抗原所引發的免疫反應皆滿足預設之不劣性標準。

將Arexvy與高劑量無添加佐劑的季節性流感疫苗同時接種時，RSV-A、RSV-B或四種中任一種流感抗原所引發的免疫反應皆滿足預設之不劣性標準。

將Arexvy與標準劑量有添加佐劑的季節性流感疫苗同時接種時，RSV-A和三種流感抗原所引發的免疫反應滿足不劣性標準，流感病毒株A/H3N2所引發的免疫反應則未能滿足預設之不劣性標準(GMT比率95%信賴區間上限為1.53；血清轉換率差異95%信賴區間上限為16.9%)。

與帶狀疱疹疫苗(基因重組、有添加佐劑)同時接種

在一項開放性第III期臨床試驗中，50歲以上的受試者被隨機分成兩組。在同時接種組中(N=265)，受試者於第1天接種一劑帶狀疱疹疫苗和一劑Arexvy，然後於第61天接種第二劑帶狀疱疹疫苗。在分開接種組中(N=265)，受試者於第1天和第61天各接種一劑帶狀疱疹疫苗，並於第31天接種一劑Arexvy。預設免疫反應不劣性標準的定義為分開接種組相比同時接種組，抗gE抗體的調整後幾何平均濃度(geometric mean concentration, GMC)比率雙邊分析95%信賴區間上限 ≤ 1.5 ，以及RSV-A與RSV-B中和效價之調整後幾何平均效價(GMT)比率雙邊分析95%信賴區間上限 ≤ 1.5 。

將這兩種疫苗同時接種時有達到預設的免疫反應不劣性標準。

與肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗(PCV20；吸附型、載體蛋白為CRM₁₉₇蛋白質)同時接種

在一項開放性第III期臨床試驗中，60歲以上的受試者被隨機分成兩組。在同時接種組中(N=553)，受試者於第1天接種一劑肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗和一劑Arexvy；在分開接種組中(N=557)，受試者於第1天接種一劑肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗，並於第31天接種一劑Arexvy。預設免疫反應不劣性標準的定義為分開接種組相比同時接種組，各肺炎鏈球菌血清型之調理吞噬抗體(opsonophagocytic antibodies, OP Ab)之調整後GMT比率雙邊分析95%信賴區間上限 ≤ 2 ，以及RSV-A與RSV-B中和效價之調整後GMT比率雙邊分析95%信賴區間上限 ≤ 1.5 。

將這兩種疫苗同時接種時有達到預設的免疫反應不劣性標準。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1劑粉劑，盛裝於附有瓶塞(丁基橡膠)的小瓶(第I型玻璃)中

1劑懸浮液，盛裝於附有瓶塞(丁基橡膠)的小瓶(第I型玻璃)中

Arexvy有1小瓶粉劑加1小瓶懸浮液的包裝，或10小瓶粉劑加10小瓶懸浮液的包裝。

13.2 效期

詳見外盒標示。

本藥品泡製後的貯存期請參見調製方式。

13.3 儲存條件

請存放於冰箱中(2°C–8°C)。

切勿冷凍。如果小瓶已經冷凍，請予以丟棄。

請置於原始包裝中保存，以避免光線照射。

本藥品泡製後的貯存條件請參見調製方式。

15 其他

不相容性

本藥品不可與其他藥品混合使用。

仿單版本：GDS11/IP109

版本日期：17 June 2025

訂閱...



(<https://accessibility.moda.gov.tw/Applications/Detail?category=20230922142826>)



衛生福利部食品藥物管理署
Food and Drug Administration

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

☎ 服務專線：02-7737-2958

✉ 服務信箱：mcp@tradevan.com.tw

🕒 服務時間：週一～週五08:30~17:30

Copyright © 2019 衛生福利部食品藥物管理署

Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare. All rights reserved.